студентов юношей было 40, девушек – 116 человек. Для анкетирования использовалась анкета профессора К.А. Шемеровского «Качество жизни». Для статистической обработки информации была использована компьютерная программа – SPSS.

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных студентов только 51 из 156 человек имеют регулярный (7 раз в неделю) ректальный ритм – 32,7%. Из них утренняя акрофаза околосуточного ритма была отмечена только у 16 человек (31,4%).

Лиц с нарушенным циркадианным ритмом дефекации оказалось 105 человек – 67,3%. Среди них диагностировано три стадии нарушения регулярности ректального ритма: I стадия (легкая) стул 5-6 раз в неделю – у 52 человек (49,5%); II стадия (умеренная) стул 3-4 раза в неделю – у 37 человек (35,2%); III стадия (тяжелая) стул 1-2 раза в неделю – у 16 человек (15,3%).

В группе студентов с нарушением регулярности ритма кишечника (105 человек) утренняя акрофаза была у 13 человек (12,4%).

Выводы:

1. У 67,3% студентов 1 курса лечебного факультета нарушен физиологический циркадианный ритм кишечника.

2. У 81,4% студентов среди всех опрошенных (156 человек) выявлен сдвиг акрофазы ритма стула (с физиологически оптимальной утренней фазы в послеполуденное время). У них отсутствует утренний стул.

3. Больше всего лиц с утренней акрофазой ритма стула выявлено при регулярном ритме кишечника (7 раз в неделю).

Для восстановления регулярности ритма стула студентам рекомендовано обогатить питание овощами и фруктами (до 500 г ежедневно); выпивать не менее 1,5-2 литров жидкости (лучше соки) ежедневно и стремиться к опорожнению кишечника именно в утренние часы.

Литература:

1. Привалова И.Л., Пашина И.В., Валуйская Ю.В. Хронофизиологические аспекты оценки показателей качества жизни у молодых людей // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2012. – № 7. – С. 184.
2. Шемеровский К.А. Запор – фактор риска колоректального рака // Клиническая медицина. – 2005. – Том 83, № 12. – С. 60-64.

## КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

*Н.И. Швец, Т.М. Бенца, О.А. Пастухова, Л.Д. Денова*

НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

E-mail авторов: bentsa_t@bigmir.net

Лечение эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа и профилактика кардиоваскулярных осложнений у этих пациентов остается сложной и далеко не решенной проблемой. Это обусловлено широкой распространенностью этих заболеваний в популяции, частым их сочетанием, ранним развитием тяжелых осложнений, высоким уровнем инвалидизации и смертности, а также недостаточно полным представлением о патогенетических механизмах этих патологических состояний [3, 5].

Как известно, СД вызывает негативные метаболические изменения в разных органах и тканях, что обусловливает их повышенную чувствительность к ишемии и выраженную дисфункцию [2]. Поэтому, перспективным направлением является исследование органопротективных возможностей метаболических препаратов, что определит новые аспекты их применения у данных больных [1, 2, 4].

Цель исследования: изучить эффективность комплексной терапии с включением триметазидина у пациентов с ЭАГ и сопутствующим СД 2 типа.

Материал и методы. Обследовано 46 больных ЭАГ II ст. в возрасте 44–66 лет, среди них 30 (65,2%) женщин и 16 (34,8%) мужчин. Пациенты были рандомизированы на 2 группы по 23 человека в каждой. Больные обеих групп в качестве базисной терапии принимали рамиприл 5-10 мг/сут в сочетании с амлодипином 5-10 мг/сут, аторвастатин 10-20 мг/сут, аспирин 75 мг/сут и сахароснижающие препараты (метформин, гликлазид или их комбинацию). Больным 2 группы дополнительно назначали препарат метаболического действия триметазидин 70 мг/сут. Всем пациентам в начале и через 24 недели наблюдения проводили суточное мониторирование артериального давления (СМАД), допплер-эхокардиографическое исследование, электрокардиографию, биохимическое исследование крови (определяли показатели липидного профиля, мочевой кислоты, креатинина, глюкозы натощак и постпрандиальной) и мочи (определяли уровень микроальбуминурии (МАУ)). По основным клинико-демографическим показателям группы 1 и 2 в начале лечения достоверно не отличались ($p>0,05$).

Результаты и обсуждение. При анализе показателей СМАД достоверных различий между группами 1 и 2 не было выявлено. Это касалось как среднесуточных, так и дневных и ночных показателей систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) и их вариабельности. Однако, во 2-й группе наблюдалась более выраженная тенденция к снижению среднесуточных и ночных уровней АД, в частности диастолического. Кроме того, у большего количества лиц 2-й группы нормализовался суточный ритм АД (по САД – у 26,1%±9,4% против 17,4%±7,9% в группе 1, по ДАД – у 30,5%±9,6% против 21,8%±8,6% в группе 1, $p>0,05$). Применение триметазидина у больных ЭАГ с СД 2 типа также способствовало стабильному снижению частоты сердечных сокращений (на 7,5%, $p<0,05$).

Дополнительное назначение триметазидина больным ЭАГ с СД 2 типа приводило к существенному улучшению диастолической (соотношение Ем/Ам увеличилось на 41,3% против 28,9% в группе 1, $p<0,05$) и сократительной функции левого желудочка (ЛЖ) (фракция выброса увеличилась на 7,9% против 4,5% в группе 1, $p<0,05$), уменьшению размера левого предсердия (ЛП) (на 10,5% против 9,0% в группе 1) и за-

метному регрессу гипертрофии ЛЖ (индекс массы миокарда ЛЖ снизился на 17,6% против 15,8% в группе 1).

Интересно, что в результате лечения показатели углеводного обмена у больных 2 группы тоже изменились достоверно (уровни глюкозы натощак и постпрандиальной снизились соответственно на 4,9% и 6,9%, $p<0,05$), чего не наблюдалось в 1-й группе. Кроме положительного влияния на гемодинамические параметры, морфо-функциональное состояние сердца, показатели углеводного обмена терапия с применением триметазидина у больных 2 группы привела к дополнительному снижению уровня МАУ на 10,3% ($p<0,1$). Положительное влияние триметазидина проявилось также в увеличении количества лиц без МАУ во 2-й группе (на 30,5%±9,6% против 17,4%±7,9% в 1-й группе).

Выводы. Таким образом, применение триметазидина на фоне базисного лечения у больных ЭАГ с сопутствующим СД 2 типа способствовало существенному улучшению диастолической и сократительной функции ЛЖ, уменьшению размера ЛП и заметному регрессу гипертрофии ЛЖ. Одновременно усиливался нефропротекторный эффект терапии в целом, а также достоверно улучшалось состояние углеводного обмена у этих пациентов. Следовательно, пациентам с ЭАГ в сочетании с СД 2 типа и признаками систолической и диастолической дисфункции ЛЖ на фоне гипертензивного и диабетического поражения почек (I-III стадии) целесообразно дополнительно назначать триметазидин 70 мг/сут.

Литература:

1. Михин В.П. Кардиоцитопротекторы – новое направление клинической кардиологии // Архив внутренней медицины. – 2011. – № 1. – С. 21-28.
2. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учеб. пос. / А.С. Аметов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1032 с.
3. Эндокринология: национальное руководство / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с.
4. Профилактика поздних макрососудистых осложнений сахарного диабета: руководство. – 2013. – 80 с.
5. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // European Heart Journal. – 2013. – Vol. 10. – P. 1093-1098.

# ХИРУРГИЯ. ОНКОЛОГИЯ

## ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

*В.И. Давыдкин, А.А. Миллер, А.Г. Голубев, Р.Р. Казаков*

НИ Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия

Острый деструктивный панкреатит является одной из наиболее частых неотложных хирургических заболеваний [1, 2], летальность достигает 12 %, а при осложнениях достигает 40 – 85,7 % [1, 4–5]. Одним из путей улучшения результатов лечения является своевременная диагностика острого панкреатита и объективный контроль за эффективностью терапии. Приводятся противоречивые данные в информативности методов лабораторной и лучевой диагностики при остром панкреатите.

Цель исследования: обоснование информативности эхоскопии в диагностике и определении оптимальной лечебно-диагностической тактики при остром панкреатите.

Материал и методы. Нами был проведен анализ результатов клинико-лабораторной и эхоскопической диагностики у 100 больных с острым панкреатитом: 69 мужчин и 31 женщина. Наибольшая частота заболевания у мужчин пришлась на возраст от 40 до 50 лет; у женщин – от 60 до 70 лет.

Всем пациентам, госпитализированным с клиникой острого панкреатита, проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование (физиклаьное обследование, оценка клинических и лабораторных показателей (диастаза мочи, общий анализ крови; уровни глюкозы, билирубина, мочевины, креатинина, общего белка, АлТ, АсТ и др.).

Первичное УЗ-исследование поджелудочной железы проведено 93 больным сразу после поступления на аппаратах Toshiba Xario, GE Vivid 7. Повторные исследования на фоне лечения проводились на 1-2, 3-4 сутки и другие сроки после поступления. Для оценки информативности УЗИ все пациенты были распределены на 4 группы: I группа – пациенты с отсутствием УЗ-данных за деструктивный процесс при поступлении и регрессом клинической картины в первые сутки лечения; II группа – пациенты с выраженной клинической картиной острого панкреатита и отсутствием УЗ-данных за деструкцию поджелудочной железы при поступлении; III группа – пациенты с эхоскопическими признаками панкреонекроза при поступлении; IV группа – пациенты с отрицательной эхоскопической картиной панкреонекроза на фоне интенсивной терапии. Результат УЗ-мониторинга оценивался по 3 критериям: отрицательная эхоскопическая динамика; положительная эхоскопическая динамика и без динамики.

Результаты и обсуждение. Ультрасонография и динамическая эхоскопия с выявила различные признаки острого панкреатита или сочетание признаков. У 18% больных не было возможности визуализировать орган. Наиболее выраженные изменения и сочетание нескольких признаков ОП выявлены у пациентов, поступивших в стационар спустя 1 сутки и более. В эти же сроки установлена высокая частота «эхонегативного периода». Данный факт требует проведения динамического сонографического обследования с целью последующей верификации диагноза и лечебной тактики.

В I группе пациентов мониторинг у 38,7% пациентов не проводился в связи с быстрым улучшением клинической картины и полным регрессом заболевания. При положительной УЗ-динамике у 19,4% терапия продолжена в том же объеме. У 19,4% в связи с отрицательной ультразвуковой динамикой терапия дополнена антибактериальными, антиферментными